หมวด	**ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)**
แผนที่	**1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)**
โครงการที่	**1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย**
ระดับการแสดงผล	**คปสอ.**
ชื่อตัวชี้วัด	**4. ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน**
คำนิยาม	**ชุมชน** หมายถึง พื้นที่ระดับตำบลตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 **ชุมชนเป้าหมาย** หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 135 ตำบล **การจัดการสุขภาพที่เหมาะสม** หมายถึง ตำบลมีการดำเนินการกิจกรรม พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีตามบริบทของชุมชนนั้นๆ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้รูปแบบการพัฒนา หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในตำบลและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 1 แห่ง ระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 1. <u>ระดับพัฒนา</u>: มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2. <u>ระดับดี</u>: มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงาน มีการจัดกิจกรรมฯ 3. <u>ระดับดีมาก</u>: มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงานมีการจัดกิจกรรมฯ มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการดำเนินงาน 4. <u>ระดับดีเยี่ยม</u>: มีทีม ข้อมูล การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีแผนงานมีการจัดกิจกรรมฯ มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน มีผลการดำเนินงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพที่ดี **ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบระดับอำเภอ** หมายถึง ตำบลมีการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีตามบริบทของชุมชนนั้นๆ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้รูปแบบการพัฒนา หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในตำบลและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ แห่งชาติ ระดับดีขึ้นไป อย่างน้อย 1 แห่ง ทุกอำเภอต้องมีตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ 1 ตำบลเพื่อส่งเป็นตัวแทนประกวด ระดับจังหวัด **กระบวนงานที่สำคัญประกอบด้วย** การชี้แจงถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ จัดทำแผนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ พัฒนาทีมพี่เลี้ยงแกนนาเครือข่ายสุขภาพระดับจังหวัด/อำเภอ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนเป้าหมาย มีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพในพื้นที่ นิเทศติดตาม การดำเนินการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพในพื้นที่ การส่งเสริมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนมีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม บันทึกผลงานในระบบ Health Gate

เกณฑ์เป้าหมาย: ร้อยละ 90 (ของตำบลเป้าหมายสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 135 ตำบล)

ตารางที่ 1 ค่าเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ร้อยละ 84 (พท.เป้าหมาย 74 ต.)	ร้อยละ 80 (พท.เป้าหมาย 95 ต.)	ร้อยละ 90 (พท.เป้าหมาย 135 ต.)	ร้อยละ 90 (พท.เป้าหมาย 135 ต.)

วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการสุขภาพของชุมชนได้
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ตำบลเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 จำนวน 135 ตำบล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. จัดเก็บจากรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มกองสุขศึกษา โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุภาพที่ 1 – 12 2. การประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนผ่านระบบการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ (Health Gate) https://healthgate.hss.moph.go.th/report 3. Dashboard ติดตามผลงาน
แหล่งข้อมูล	ระบบการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ (Health Gate)

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมและตัดข้อมูล :

: ข้อมูลการตรวจราชการระดับจังหวัด ใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบันก่อนลงพื้นที่ตรวจราชการ

: รอบที่ 1 ระยะเวลาประเมินผลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568- มีนาคม 2569) : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

: รอบที่ 2 ระยะเวลาประเมินผลรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2568- กรกฎาคม 2569) : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B)x100
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนตำบลที่มีการดำเนินงานจัดการสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (135 ตำบล)
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนตำบลเป้าหมาย 135 ตำบล
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 2 3 และ 4
วิธีการประเมินผล :	ประเมินผ่านระบบการประเมินการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ Health Gate
เอกสารสนับสนุน :	-

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกาฬสินธุ์

Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
		2566	2567	2568
ระดับความสำเร็จของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน	ร้อยละ (แห่ง)	87 (100%)	84 (100%)	80 (84.21%)

เกณฑ์การประเมิน : ระดับ คปสอ. ปีงบประมาณ 2569
ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน
รอบ 5 เดือน
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินผลเชิงปริมาณ :
วิธีการประเมินผล : เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย	
รอบ 6 เดือน	**รอบ 10 เดือน**
ร้อยละ 50	ร้อยละ 90

เอกสาร/หลักฐานสนับสนุน : 1. ผลการประเมินในระบบ Health Gate 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณในแต่ละระดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569) ดังนี้

คะแนน	เกณฑ์ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	เกณฑ์ผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน
10	ร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ 90 ขึ้นไป
9	ร้อยละ 45-49	ร้อยละ 85-89
8	ร้อยละ 40-44	ร้อยละ 80-84
7	ร้อยละ 35-39	ร้อยละ 75-79
6	ร้อยละ 30-34	ร้อยละ 70-74
5	ร้อยละ 25-29	ร้อยละ 65-69
4	ร้อยละ 20-24	ร้อยละ 60-64
3	ร้อยละ 15-19	ร้อยละ 55-59
2	ร้อยละ 10-14	ร้อยละ 50-54
1	น้อยกว่าร้อยละ 10	น้อยกว่าร้อยละ 50

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะนนเชิงปริมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้ออกแบบเกณฑ์ผลการ ดำเนินงานแต่ละระดับ โดยระบุเกณฑ์คะแนน 1–10 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย

ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินผลเชิงคุณภาพ ด้านผลลัพธ์ (Outcome) กรอบแนวคิด CIPP Model

เกณฑ์การประเมินผล	หัวข้อการประเมิน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 1 0 – 40 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 2 41 – 55 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 56 – 70 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 4 71- 85 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 5 86 – 100 คะแนน	เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประเมิน
ด้านบริบท	สร้างความร่วมมือกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพร่วมกับภาคี เครือข่าย	o มีผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับจังหวัด	o มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง o มีการประสานงานระหว่างเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	o มีนโยบายการ ดำเนินงาน o มีคณะทำงาน	o มีนโยบายการดำเนินงาน o มีการสื่อสารนโยบายมี O คณะทำงานขับเคลื่อนงานใน สังกัด สธ.	o มีนโยบายการ ดำเนินงาน O มีการสื่อสารนโยบาย O มีคณะทำงานขับเคลื่อนงานทั้งในและ นอกสังกัด สธ.	1.นโยบาย 2.การสื่อสาร/ แจ้งนโยบาย 3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านปัจจัยนำเข้า	แผนการดำเนินพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ	o มีแนวทางการดำเนินงาน ระดับจังหวัด	o มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน o มีแผนการดำเนินงาน ระดับจังหวัด	o มีแผนการดำเนินงานระดับ จังหวัด ที่เกิดจาก การมีส่วนร่วม ของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	o มีแผนการดำเนินงานระดับจังหวัด ที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง o มีการถ่ายทอด แผนสู่การปฏิบัติให้กับเครือข่ายในสังกัด สธ.	o มีแผนการดำเนินงาน ฯ ที่เกิดจากการมีส่วน ร่วมของเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งในและนอก หน่วยงาน o แผนการดำเนินงานครอบคลุมทั้ง จังหวัด o มีการถ่ายทอดแผนสู่ การปฏิบัติให้กับเครือข่าย ทั้งในและ นอกสังกัด สธ	1.แผนฯ 2.สรุปการประชุม/ หนังสือแจ้ง เวียน

เกณฑ์การประเมินผล	หัวข้อการประเมิน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 1 0 – 40 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 2 41 – 55 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 56 – 70 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 4 71- 85 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 5 86 – 100 คะแนน	เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประเมิน
ด้านกระบวนการ	ดำเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	o พัฒนาพี่เลี้ยงระดับ จว.	o พัฒนาพี่เลี้ยงระดับ จว./อ. o พัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ต.ละ 1 คนและอาสาสร้างสุขภาพใน โรงเรียน ๆ ละ 10 คน	o พัฒนาพี่เลี้ยงระดับ จว./อ. o พัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ต.ละ 1 คนและอาสาสร้างสุขภาพใน โรงเรียน ๆ ละ 10 คน o ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ	o พัฒนาพี่เลี้ยงระดับ จว./อ. o พัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ผู้นำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ต.ละ 1 คนและอาสาสร้างสุขภาพใน โรงเรียน ๆ ละ 10 คน o ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน จัดการสุขภาพ o ประเมินผล ชุมชนผ่านระบบ Health Gate	O พัฒนาพี่เลี้ยงระดับ จว./อ. o พัฒนาศักยภาพแกน นำ อสม.ผู้นำการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ ต.ละ 1 คนและ อาสาสร้างสุขภาพใน โรงเรียน ๆ ละ 10 คน o ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ o ประเมินผลชุมชน ผ่านระบบ Health Gate ครอบคลุมทุก อำเภอ o นิเทศ ติดตาม เสริมพลัง	1.รายงานผล การพัฒนา ศักยภาพพี่เลี้ยงระดับ จว./อ, 2.รายงานผล การพัฒนา ศักยภาพแกน นำ อสม./อาสา สร้างสุขภาพใน โรงเรียน 3. การ สนับสนุนการ พัฒนาและใช้ระบบการ ประเมินชุมชน (Health Gate) 4.สรุปปัญหาอุปสรรคของการพัฒนา ชุมชนจัดการ สุขภาพ

เกณฑ์การประเมินผล	หัวข้อการประเมิน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 1 0 – 40 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 2 41 – 55 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 3 56 – 70 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 4 71- 85 คะแนน	เกณฑ์คุณภาพ ระดับ 5 86 – 100 คะแนน	เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประเมิน
ด้านผลลัพธ์	การประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผน	o ผลการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 60 ขึ้นไป	o ผลการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 70 ขึ้นไป	O ผลการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 80 ขึ้นไป o มีพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับจังหวัด	o ผลการดำเนินงานตามแผน ร้อยละ 90 o มีพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ	o ผลการดำเนินงาน ตามแผนมากกว่าหรือ เท่ากับ ร้อยละ 90 o มีพื้นที่ต้นแบบชุมชนจัดการสุขภาพ ระดับประเทศ และ/หรือ เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับเขต/ประเทศ o มีแนวทางการ ปรับปรุงพัฒนา	1.ผลการดำเนินงาน 2.แนวทางการพัฒนา

เกณฑ์การให้คะแนนเชิงคุณภาพ ด้านผลลัพธ์ หลักการให้คะแนนเชิงคุณภาพ

1) คะแนนรวม 100 คะแนนต่อหนึ่งตัวชี้วัด

: หากตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับหลาย Building Block (เช่น 6 ด้าน) ให้ใช้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในการประเมินรวมทุกด้านนั้น

2) คะแนนเต็มของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ = 100 คะแนน

: หากในแต่ละด้านมีหลายหัวข้อการประเมิน ให้รวมคะแนนทุกหัวข้อในส่วนนั้นให้เท่ากับ 100 คะแนน

3) คำนวณคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

: เช่น (68 + 40 + 60 + 85) ÷ 4 = 63.25 คะแนน

ตารางที่ 5 การแปลผลระดับคุณภาพและระดับคะแนนการพัฒนา (5 ระดับ)

ระดับคุณภาพ	ช่วงคะแนน	การแปลผลเชิงคุณภาพ	ระดับการพัฒนา
ระดับ 5 = ดีเยี่ยม (Excellent)	86 – 100	การขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ ดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดี ปรับปรุงต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ	ยั่งยืนและเป็นต้นแบบ
ระดับ 4 = ดี (Good)	71 – 85	การขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ มีความมั่นคง ครอบคลุม และมีการพัฒนาต่อเนื่อง	พัฒนาอย่างมั่นคง
ระดับ 3 = พอใช้ (Fair)	56 – 70	การขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ ดำเนินการได้ตามมาตรฐานพื้นฐาน มีบางส่วนต้องปรับปรุง	กำลังพัฒนา
ระดับ 2 = ต้องพัฒนา (Developing)	41 – 55	การขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ ไม่มั่นคง ต้องเร่งปรับปรุงในหลายองค์ประกอบ	ต้องการการสนับสนุน
ระดับ 1 = ต้องเร่งแก้ไข (Critical)	ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 40	การขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ ยังไม่เป็นรูปธรรม ขาดการมีส่วนร่วมและแผนการดำเนินงาน ที่ชัดเจน	ต้องการฟื้นฟูระบบ

หลักการคิดสัดส่วนผลสัมฤทธิ์ของการประเมินตัวชี้วัดการตรวจราชการ คิดอัตราส่วน 70 : 30

: สัดส่วน 70 คือ ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ

: สัดส่วน 30 คือ ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ (Outcome หรือ Impact)

ตารางที่ 6 การคำนวณคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดการตรวจราชการ คิดอัตราส่วน 70 : 30

ระดับคะแนนเชิงปริมาณ (70%)	ระดับคะแนนเชิงคุณภาพ ด้านผลลัพธ์ (30%)
ระดับคะแนนที่ได้ x 0.7 = Score	(คะแนนที่ได้÷10) x 0.3 = Score
Score เชิงปริมาณ + Score เชิงคุณภาพ = (คะแนนเต็ม 10)	

ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลระดับความสำเร็จของร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน

คะแนน	เกณฑ์ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน	เกณฑ์ผลการดำเนินงาน รอบ 10 เดือน	ระดับความสำเร็จ
10	ร้อยละ 50 ขึ้นไป	ร้อยละ 90 ขึ้นไป	5
9	ร้อยละ 45-49	ร้อยละ 85-89	4
8	ร้อยละ 40-44	ร้อยละ 80-84	3
7	ร้อยละ 35-39	ร้อยละ 75-79	2
6	น้อยกว่าร้อยละ 35	น้อยกว่าร้อยละ 75	1

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน ร้อยละ 90

1.ระดับความสำเร็จของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน ร้อยละ 90

: รอบที่ 1 ระยะเวลาประเมินผลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568- มีนาคม 2569) : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ระดับความสำเร็จ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน)	<35	35-39	40-44	45-49	≥ 50

: รอบที่ 2 ระยะเวลาประเมินผลรอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2568- กรกฎาคม 2569) : ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ระดับความสำเร็จ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน)	<75	75-79	80-84	85-89	≥ 90

ผู้กำกับตัวชี้วัด (รองนพ.สสจ. ผู้ควบคุมกำกับกลุ่มงาน)	นายจักราวุฒิ วงษ์ภักดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ โทร 0816011408 E – mail : - สถานที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายวรชาติ จำเริญพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 04 301 9760 ต่อ 5 โทรศัพท์มือถือ : 09 4296 4635 E – mail : worachat.j@hotmail.com สถานที่ทำงาน : กลุ่มงานปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพ
ผู้ประสานการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0 4301 9760 ต่อ 5 โทรศัพท์มือถือ : 06 2356 5562 E – mail : wangphusit272@gmail.com สถานที่ทำงาน : กลุ่มงานปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพ
ผู้ประสานการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน	นายเอื้ออังกูร มหัทธนะวรสิริ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ : 063-0375887 E-mail :. euaangkul08032516@gmail.com สถานที่ทำงาน : กลุ่มงานปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพ

ตารางที่ 8 เป้าหมายการดำเนินงานชุมชนจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เขตสุขภาพ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ชุมชนเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แห่ง)
7	กาฬสินธุ์	18	135	1,620

ลำดับ	อำเภอ	ตำบล
1	เมืองกาฬสินธุ์	17
2	นามน	5
3	กมลาไสย	8
4	ร่องคำ	3
5	กุฉินารายณ์	12
6	เขาวง	6
7	ยางตลาด	15
8	ห้วยเม็ก	9
9	สหัสขันธ์	8
10	คำม่วง	6
11	ท่าคันโท	6
12	หนองกุงศรี	9
13	สมเด็จ	8
14	ห้วยผึ้ง	4
15	สามชัย	4
16	นาคู	5
17	ดอนจาน	5
18	ฆ้องชัย	5
	รวม	135